

1. Introducción y relevancia clínica

La **enfermedad diverticular del colon** comprende un espectro que va desde la presencia asintomática de **divertículos (diverticulosis)** hasta la **inflamación o infección diverticular (diverticulitis aguda)** y sus complicaciones (absceso, perforación, peritonitis o fístulas).

Es **una de las causas más frecuentes de abdomen agudo en adultos mayores** y una causa común de consulta en urgencias quirúrgicas.

En Chile, su incidencia ha aumentado significativamente con el envejecimiento poblacional y los hábitos alimentarios bajos en fibra.

- A los 60 años, hasta el **50% de la población** presenta diverticulosis.
 - Solo **10–25%** desarrollará **diverticulitis** en su vida.
 - Es la **causa más frecuente de hemorragia digestiva baja** en mayores de 60 años.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Definiciones

- **Divertículo colónico:** evaginación de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular (falso divertículo).
 - **Diverticulosis:** presencia de divertículos sin inflamación.
 - **Diverticulitis:** inflamación e infección de uno o varios divertículos.
 - **Enfermedad diverticular complicada:** presencia de absceso, perforación, peritonitis, obstrucción o fístula.
-

2.2 Mecanismos fisiopatológicos

1. **Aumento de presión intraluminal** por dieta baja en fibra → contracciones segmentarias.
2. **Debilidad focal de la pared intestinal** en zonas de penetración vascular.
3. **Microperforación diverticular** → inflamación local → absceso o peritonitis.
4. Si hay comunicación con otras estructuras → **fístulas** (colovesical, colovaginal).

Los divertículos se concentran en el **colon sigmoide (95%)**, debido a su pequeño calibre y mayor presión intraluminal.

2.3 Factores de riesgo

- Dieta baja en fibra.
 - Edad avanzada.
 - Obesidad y sedentarismo.
 - Constipación crónica.
 - Uso prolongado de AINES, esteroides o opioides.
 - Tabaquismo.
 - Historia familiar de enfermedad diverticular complicada.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Diverticulosis (fase asintomática)

- Generalmente **asintomática**.
 - Puede manifestarse por **hemorragia digestiva baja indolora** (hematochezia o rectorragia).
 - No hay fiebre ni dolor abdominal.
-

3.2 Diverticulitis aguda (fase inflamatoria)

Síntomas clásicos

- **Dolor en fosa iliaca izquierda** (localización sigmoidea).
- **Fiebre, náuseas y vómitos.**
- **Alteración del tránsito intestinal:** constipación o diarrea.
- En casos severos: distensión abdominal, irritación peritoneal.

En pacientes asiáticos, los divertículos suelen estar en colon derecho, por lo que el dolor puede simular una **apendicitis**.

Signos físicos

- Dolor a la palpación en FII.
- Defensa localizada (peritonitis localizada).
- Posible masa palpable (absceso).
- Signo de Blumberg positivo si hay peritonitis.

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias clave
Apendicitis aguda	Dolor en FID, no FII.
Cáncer colorrectal	Sangrado crónico, pérdida de peso, sin fiebre.
Colitis isquémica o infecciosa	Diarrea sanguinolenta y compromiso sistémico.
Síndrome de intestino irritable	Crónico, sin fiebre ni leucocitosis.

Ginecológico (EIP, torsión ovárica)

Dolor pélvico, flujo o alteraciones menstruales.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

- **Leucocitosis (>10.000–12.000).**
- **PCR elevada.**
- **Electrolitos y función renal (control de sepsis y deshidratación).**
- **Hemoglobina:** puede disminuir si hay sangrado.

4.2 Imágenes

A. TAC abdominopélvico con contraste

(Gold Standard)

Permite confirmar el diagnóstico y clasificar la severidad:

- Engrosamiento parietal del colon (>4 mm).
- Grasa pericolónica con densidad aumentada (“fat stranding”).
- Presencia de abscesos o burbujas de aire extraluminal.
- Evalúa complicaciones (fístulas, obstrucción, perforación).

B. Ecografía abdominal

- Alternativa inicial en urgencias.
- Detecta abscesos o líquido libre.

- Menos sensible que TAC.

C. Colonoscopia

- **Contraindicada en fase aguda** (riesgo de perforación).
- Indicada **6–8 semanas después del cuadro agudo**, para descartar cáncer colorrectal.

4.3 Clasificación de Hinchey (para diverticulitis complicada)

Grado	Descripción	Manejo
I	Absceso pericólico o mesentérico	Antibióticos ± drenaje percutáneo
II	Absceso pélvico	Drenaje percutáneo o quirúrgico
III	Peritonitis purulenta generalizada	Cirugía urgente
IV	Peritonitis fecal	Cirugía urgente con resección

5. Tratamiento (según guías MINSAL / WSES 2020)

5.1 Principios generales

- Reposo digestivo (ayuno o dieta líquida clara).
- Hidratación parenteral.
- Analgesia (evitar AINES).

- Antibióticos según severidad.
-

5.2 Tratamiento según tipo de enfermedad

A. Diverticulitis no complicada (Hinchey 0–I)

- Manejo ambulatorio o intrahospitalario según caso.
- Antibióticos orales por 7–10 días:
 - *Amoxicilina/Ácido clavulánico 875/125 mg c/12h*, o
 - *Ciprofloxacino + Metronidazol*.
- Reposo y dieta progresiva.
- Reevaluación a las 48–72 h.

En pacientes jóvenes, sin comorbilidades y sin fiebre alta puede omitirse antibiótico, según evidencia reciente.

B. Diverticulitis complicada (Hinchey II–IV)

1. Absceso pericólico o pélvico (II)

- Antibioticoterapia IV:
 - *Piperacilina/Tazobactam*, o
 - *Ceftriaxona + Metronidazol*.
- Drenaje percutáneo guiado por TAC si >3–4 cm.
- Cirugía si no responde.

2. Peritonitis purulenta o fecal (III–IV)

- Cirugía urgente:
 - *Hartmann clásico*: resección del segmento afectado + colostomía terminal.
 - *Anastomosis primaria* (en pacientes seleccionados estables).

- Drenaje amplio y lavado peritoneal.
 - Antibióticos IV de amplio espectro.
-

C. Diverticulitis recurrente

- Indicación de **resección electiva del sigmoides** tras:
 - ≥ 2 episodios en pacientes < 50 años, o
 - ≥ 3 episodios en mayores, o
 - Complicaciones (fístulas, absceso persistente).
 - Técnica habitual: **sigmoidectomía laparoscópica con anastomosis primaria.**
-

5.3 Hemorragia diverticular

- Autolimitada en **80–90% de los casos.**
 - Colonoscopia con hemostasia endoscópica (adrenalina, clip).
 - En sangrado persistente: embolización angiográfica o cirugía segmentaria.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Manifestación clínica	Manejo
Absceso	Fiebre persistente, masa palpable	Drenaje percutáneo o quirúrgico
Perforación y peritonitis	Abdomen agudo, sepsis	Cirugía urgente

Obstrucción colónica	Estreñimiento, vómitos, distensión	Resección o derivación
Fístula colovesical	Neumaturia, infecciones urinarias repetidas	Resección + cierre vesical
Hemorragia digestiva baja	Rectorragia indolora	Endoscopia / Embolización

Pronóstico:

- Mortalidad global <5% en casos no complicados.
- En perforación peritoneal: mortalidad hasta 40%.
- Riesgo de recurrencia tras primer episodio: 10–30%.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dolor en FII + fiebre + leucocitosis = diverticulitis hasta demostrar lo contrario.**
 2. **TAC con contraste** es el **examen de elección** para confirmar el diagnóstico y clasificar la severidad.
 3. **Nunca realizar colonoscopia en fase aguda.**
 4. **Absceso >4 cm → drenaje percutáneo.**
 5. **Recurrente o complicada → cirugía electiva.**
 6. **Cáncer colorrectal debe descartarse siempre después de un episodio.**
 7. **Manejo ambulatorio** posible en cuadros leves, con buena adherencia y control.
-



Errores comunes

- Tratar empíricamente sin confirmar con imagen.
 - Realizar colonoscopia o enema baritado durante el cuadro agudo.
 - Usar AINES o laxantes estimulantes.
 - No indicar drenaje ante abscesos grandes.
 - No descartar cáncer tras resolución.
 - Indicar cirugía precoz innecesaria tras un único episodio leve.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **enfermedad diverticular** incluye desde la **diverticulosis asintomática** hasta la **diverticulitis complicada**.
2. El **dolor en FII, fiebre y leucocitosis** son signos típicos de diverticulitis.
3. El **TAC con contraste** es el examen diagnóstico y de clasificación principal.
4. El tratamiento depende del grado: **antibióticos** en leves, **drenaje o cirugía** en complicadas.
5. **No realizar colonoscopia en fase aguda**, pero sí de control a las 6–8 semanas.
6. **Recurrencia o complicaciones** son indicación de resección electiva del sigmoides.
7. **Hemorragia diverticular** es la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo en adultos mayores.